

Um:bruch

re:shape – Denkfabrik für gesellschaftlichen Wandel

POSITIONSPAPIER ST-001 ES

Executive Summary

Systemtheoretische Aufarbeitung der Regressangst — ST-001 v0.22

Um:bruch – Denkfabrik für gesellschaftlichen Wandel | April 2026 | Version 1.3

Schlagworte: Regress, Wirtschaftlichkeitsprüfung, V2b, Transparenz, Executive Summary

Zusammenfassung. Das Wirtschaftlichkeitsprüfsystem nach §§ 106 ff. SGB V erzeugt eine Regressangst, deren Folgekosten die durchgesetzten Regresse nach Modellrechnung um das 100- bis 1.000-fache übersteigen könnten. Die Studie ST-001 identifiziert 15 Befunde, die diese Diskrepanz aus historischen, rechtsdogmatischen, verhaltensökonomischen und international vergleichenden Quellen aufklären. **Genre und Geltungsanspruch:** ST-001 ist keine Original-Studie im Sinne einer neuen empirischen Primärerhebung, sondern eine **multiperspektivische Bestandsaufnahme mit Pilot-Charakter** — eine Diagnose-Konstruktion (drei Zertifikatsfehler) auf Basis integrierter rechtsdogmatischer, statistischer, verhaltensökonomischer und institutionentheoretischer Perspektiven. 15 Befunde, drei minimal-invasive Reformhebel und 15 bewertete Maßnahmen (KNV-Tabelle) bieten konkrete Handlungsoptionen für Politik, Verbände und Zivilgesellschaft.

1 Forschungsfrage

Die Studie untersucht eine auffällige Diskrepanz im deutschen Wirtschaftlichkeitsprüfsystem nach §§ 106 ff. SGB V: Die offizielle Regressdurchsetzungsquote liegt unter 1 % der Vertragsärzte (je nach KV-Bezirk 0,065–0,8 %) — dennoch berichten 72 % der Hausärzte, mindestens einmal einen Regress erlebt zu haben (Ribbat et al. 2023, n=770), und 47 % geben an, die Regressgefahr beschäftige ihren Praxisalltag „stark oder sehr stark“. Die zentrale Frage lautet: **Was passiert im System, das beides zugleich produziert?** Die Studie versucht, diese Diskrepanz aus historischen, rechtsdogmatischen, verhaltensökonomischen, gesundheitsökonomischen und international vergleichenden Quellen aufzuklären.

ST-001 ist die wissenschaftliche Begleituntersuchung zum Konzeptpapier PP-003 (Regress-Transparenzportal).

2 Zentrale Befunde

Die Studie identifiziert 15 wesentliche Befunde, die hier mit ihrer jeweiligen Evidenzbasis und ihren Einschränkungen dargestellt werden.

2.1 Vier Messebenen und ihre Vermischung

Befund: Der Begriff „Regressquote“ wird in der öffentlichen Diskussion für vier grundlegend verschiedene Messgrößen verwendet: Prüfquote, Regressverfahrenquote, Regressdurchsetzungsquote und Regressvolumen. Diese vier Ebenen sind nicht miteinander vergleichbar, werden aber regelmäßig vermischt. Die öffentlich kommunizierte „unter 1 %“-Zahl bezieht sich auf die Regressdurchsetzungsquote auf Arztebene, über beide Verfahren (V1+V2) hinweg, ohne Verfahrenstrennung. Die 99,7-%-Verwerfungsrate (KV Hessen 2015) misst hingegen die Pipeline-Verwerfungsrate der Auffälligkeitsprüfung (V1) allein.

Evidenzbasis: KV-Statistiken (KV Hessen 2015, Dt. Ärzteblatt Art. 113630; KV BaWü 2022), eigene systematische Begriffsanalyse.

Einschränkung: Bundesweit fehlen alle vier Ebenen als einheitlich veröffentlichte Zahlen. Keine KV publiziert verfahrensgetrennte (V1 vs. V2) Statistiken.

2.2 Definitionsdivergenz: Warum “unter 1 %” und “72 %” kein Widerspruch sind (CORE4)

Befund: Der Begriff “Regress” wird von verschiedenen Akteuren unterschiedlich definiert. Diese Definitionsdivergenz erklärt die scheinbare Diskrepanz:

Schicht	Was gezählt wird	Zahl	Quelle
1 (eng)	Nur V1, rechtskräftig	<100/J → 0,065 %	Virchowbund 2018
2 (amtlich)	V1+V2, rechtskräftig	21/21.500 → 0,097 %	KV BaWü 2022
3 (faktisch)	Alle V2 inkl. Vergleiche	ca. 47.000/J → ~30 %	BMG GVSG 2024

Der Faktor zwischen Schicht 1 und Schicht 3 beträgt ca. 470–500×. Alle Akteure sagen die Wahrheit — über verschiedene Messgrößen. Die Diskrepanz ist **kein Wahrnehmungsfehler der Ärzte, sondern ein Messproblem der Statistik**. In Bayern meldet der SpiFa 13.332 festgesetzte Regresse (2024) bei ~24.000 Vertragsärzten — Durchschnittsbetrag 334 EUR, ~70 % davon Bagatelle unter 300 EUR.

Evidenzbasis: BMG GVSG-Referentenentwurf 2024; SpiFa Bayern 2023/2024; Virchowbund 2018; KV BaWü 2022; Multi-Agenten-Recherche (15 Agenten, 25 Datenpunkte, 14 Domains).

Einschränkung: Die Schätzung “~30 %” basiert auf der Annahme gleichmäßiger Verteilung der 47.000 Verfahren auf 155.000 Ärzte. Die tatsächliche Verteilung (nach Fachgruppe, Region, Kassenart) ist nicht publiziert.

Originalität: Nach systematischem Prior-Art-Check (Opus-Agent, 20+ Suchanfragen) ist die Synthese — Definitionsdivergenz als Erklärung für die Ribbat-Diskrepanz — **nirgends publiziert**. Die gesamte Literatur erklärt die Diskrepanz als psychologisches Problem der Ärzte (Availability Bias, irrationale Angst). Alle Einzelbausteine (Ribbat, BMG, SpiFa, Virchowbund) sind publiziert; die Verbindung ist originär.

2.3 Zwei Prüfdomänen (V1/V2) und ihre unterschiedliche Fairness

Befund: Das Wirtschaftlichkeitsprüfsystem besteht aus zwei funktional inkommensurablen Verfahren:

- **V1 (Auffälligkeitsprüfung, § 106 SGB V):** Statistisches Screening, initiiert von der Prüfungsstelle, ohne individuellen Verdacht. Breiter Filter mit hoher Sensitivität und niedriger Spezifität — eine hohe Verwerfungsrate (99,7 %) ist die normale Funktionsweise.
- **V2 (Einzelfallprüfung, § 106b SGB V):** Antragsgebundenes Verdachtsverfahren, initiiert von der Krankenkasse. Gesetzlich ohne „Beratung vor Regress“ (§ 106b Abs. 2 S. 4 SGB V). Kasse ist gleichzeitig Antragstellerin und Empfängerin des Regressbetrags.

V1 hat über die Jahre Schutzschichten dazubekommen (Beratung vor Regress 2012, Praxisbesonderheiten 2011, Richtgrößen abgeschafft 2015). V2 blieb explizit ohne Beratungsschutz — das war kein Übersehen, sondern bewusstes gesetzliches Design.

Evidenzbasis: Gesetzestexte (SGB V, GKV-VSG 2015), BSG-Rechtsprechung, KBV-Stellungnahme zum GKV-VSG 2015, regionale Prüfvereinbarungen.

Einschränkung: V2-Daten existieren (BMG: ca. 47.000 Verfahren bundesweit 2022; SpiFa Bayern: 13.000 Regresse/Jahr), werden aber nicht als integrierte Durchsetzungsstatistik mit Verwerfungs- und Vergleichsquoten publiziert. Keine KV publiziert verfahrensgetreunte (V1 vs. V2) Pipeline-Daten.

2.4 V2a vs. V2b — die entscheidende Differenzierung (CORE3), V2b-Binnendifferenzierung (v0.14)

Befund: Die Einzelfallprüfung (V2) zerfällt in zwei Unterkategorien mit fundamental verschiedener Verfahrenslogik, V2b ist zusätzlich binnendifferenziert:

- **V2a (Unwirtschaftliche Verordnung):** Leitlinienkonform, aber teurer als nötig. Medizinische Verteidigung möglich; die Kostendifferenzmethode (§ 106b Abs. 2a SGB V, BSG 2024) begrenzt den Regress auf die Differenz zur wirtschaftlichen Alternative.
- **V2b (Unzulässige Verordnung):** Medizinische Gründe grundsätzlich irrelevant (normativer Schadensbegriff, BSG B 6 KA 5/09 R); keine Kostendifferenzmethode; keine Heilbarkeit nach Bezahlung durch die Kasse; kein Beratungsschutz. Intern binnendifferenziert:
 - **V2b (i) — reine Formfehler** (fehlende Unterschrift, Stempel statt Unterschrift, fehlende ICD, falsches Aut-idem-Kreuz): Formkonformität ist kein Proxy für medizinische Qualität. Voller Zertifikatsfehler.
 - **V2b (ii) — inhaltliche Unzulässigkeit** (AM-RL-Verstoß, Off-Label ohne Begründung, AMNOG-Ausschluss): Die Formregel codiert bereits medizinische G-BA-Evidenz; der Zertifikatsfehler ist schwächer, weil die Regel medizinische Qualität *mittelbar* misst — das Problem ist die punitive Kommunikation statt eines Lernsignals.

Konsequenz für das Gesamtbild:

- V1 ist **fairer als in frühen Versionen der Studie dargestellt** (Anhörung, medizinische Berücksichtigung, Stufenmodell).
- V2a hat **Verteidigungsmöglichkeiten** (medizinische Begründung, Kostendifferenz).

- V2b ist **isoliert betrachtet noch problematischer** als bisher dargestellt: Es ist das einzige Verfahren im deutschen Recht ohne Heilungsmöglichkeit, ohne Kostendifferenz, ohne medizinische Relevanz.

Quantitative Einschätzung (v1.2). Nicht *alle* V2-Verfahren sind dysfunktional. Geschätzt **60–65 % der V2-Verfahren** (Kategorie B reine Formfehler + verfahrensfremde Angriffsvektoren wie der Stempel-Regress) fallen unter den zweiten Zertifikatsfehler; die restlichen 35–40 % (Kategorie A: evidenzbasierte Formregeln — AM-RL-Anlagen, G-BA-Beschlüsse, Biosimilar-Pflicht) codieren medizinische Evidenz — allerdings über den punitiven statt den edukativen Kanal. Die Forderung der Studie ist deshalb nicht die Abschaffung der Evidenzsteuerung, sondern die Ergänzung des punitiven Kanals um einen edukativen (Beratungsschutz auch bei V2, Vorabinformation, Hebel 1).

Evidenzbasis: GPE BaWü, KV Nordrhein, KV Bayern, BSG-Rechtsprechung (B 6 KA 5/09 R, B 6 KA 5/23 R, B 6 KA 27/12 R), eigene Detailrecherche (CORE3-Dokument).

Einschränkung: Die V2a/V2b-Differenzierung wird in keiner offiziellen Statistik abgebildet. Welcher Anteil der V2-Verfahren V2a und welcher V2b betrifft, ist nicht öffentlich bekannt.

2.5 Drei Zertifikatsfehler — doppelt im Messinhalt, einmal in der Messrichtung

Befund: Das Regresssystem weist drei Zertifikatsfehler auf — zwei im Messinhalt, einen übergeordneten in der Messrichtung:

1. **Erster Zertifikatsfehler — V1 (Kostenabweichung $\neq$ Medizin):** Die Auffälligkeitsprüfung misst Kostenabweichung vom Fachgruppendurchschnitt, nicht medizinische Qualität. Für ein Screening ist das technisch korrekt; der Fehler liegt in der öffentlichen Interpretation der niedrigen Endquote als Beleg für ein „funktionierendes System“. Das Schutzstufenmodell filtert fast vollständig.
2. **Zweiter Zertifikatsfehler — V2b (Form $\neq$ Medizin):** Die Einzelfallprüfung beansprucht, medizinische Unwirtschaftlichkeit zu prüfen. Sie misst faktisch formale bzw. zulassungsrechtliche Angreifbarkeit. Der Befund gilt in voller Schärfe für V2b (i) (reine Formfehler); bei V2b (ii) (inhaltliche Unzulässigkeit, AM-RL-Verstoß) ist er abgeschwächt, weil die Formregel G-BA-Evidenz codiert — das Problem bleibt die punitive statt edukative Kommunikation.
3. **Übergeordneter Zertifikatsfehler — Einbahnprüfung (Richtung $\neq$ Symmetrie):** Das gesamte System prüft ausschließlich „zu viel verordnet“, nie „zu wenig versorgt“. Der Versorgungsauftrag des § 70 SGB V hat kein eigenes Messinstrument im ambulanten Bereich. Damit verschiebt das System den Schaden vom Arzt zum Patienten: Der Arzt ist bei Handeln dem Regressrisiko ausgesetzt; der Patient trägt bei ärztlicher Zurückhaltung die Unterversorgung und bei ärztlicher Ausweichreaktion die Überversorgung (iatrogene Risiken + finanziell/zeitliche Zuzahlungen, Fahrtwege, Arbeits-/Urlaubszeit). SVR-Trias: Unter-/Über-/Fehlversorgung (SVR 2000/2001, § 135a SGB V).

Medizinische Angemessenheit im Sinne des § 12 Abs. 1 SGB V und der Versorgungsauftrag des § 70 SGB V werden systematisch nur außerhalb des Regresssystems zertifiziert (Schlichtungsstellen der Ärztekammern, zivilrechtliche Arzthaftung, keine operative Versorgungsprüfung im ambulanten Bereich).

Evidenzbasis: Systematische Analyse aller Prüfstufen (Pipeline-Diagramme); BSG-Rechtsprechung; §§ 12, 70, 135a SGB V; Goodhart's Law / Campbell's Law; SVR-Gutachten 2000/2001.

Einschränkung: Der Einwand, das System habe nie ein medizinisches Qualitätsversprechen gegeben, ist dogmatisch zutreffend (Einwand 2 der Studie). Der Zertifikatsfehler beschreibt nicht einen Fehler *im* System, sondern die Lücke zwischen Systemmessung und öffentlicher Bedeutungszuschreibung. V1 berücksichtigt medizinische Besonderheiten im Schutzstufenmodell; V2a lässt medizinische Verteidigung zu; V2b (ii) codiert G-BA-Evidenz. Der übergeordnete Richtungsfehler gilt für *alle* Verfahren gleichermaßen.

2.6 V1-Schutzstufenmodell

Befund: Die Auffälligkeitsprüfung (V1) enthält ein mehrstufiges Schutzmodell, das in der öffentlichen Debatte bisher wenig gewürdigt wurde:

Stufe	Schutzwirkung
Anhörung / Stellungnahme Praxisbesonderheiten	Arzt kann Abweichung erklären (6 Wochen Frist) Medizinische Besonderheiten der Patientenstruktur werden berücksichtigt
Beratung statt Regress	Bei erstmaliger Auffälligkeit: Beratung als Regelungsentscheidung nach § 106b Abs. 2 S. 2 SGB V — sie <i>ersetzt</i> den Regress im Erstzyklus rechtsverbindlich, ist nicht Vorstufe
Karenzzeit	Erst im nächsten Zeitraum prüfbar
Deckel	25.000 EUR in den ersten zwei Jahren nach Beratung
5-Jahres-Regel	Nach 5 Jahren ohne Auffälligkeit gilt man wieder als erstmalig

Die 99,7%-Verwerfungsrate ist das Ergebnis eines **funktionierenden Schutzstufenmodells**, nicht eines dysfunktionalen Filters.

Evidenzbasis: GPE BaWü, KV Nordrhein, § 106b Abs. 2 SGB V.

Einschränkung: Alle markierten Ärzte tragen dennoch die psychologischen Kosten des Screenings (Angst, Aufwand), auch die 99,7 %, die entlastet werden. Praxisbesonderheiten müssen aktiv geltend gemacht werden — wer das nicht weiß, verliert.

2.7 Ribbat 72 % — Regresserfahrung ohne Verfahrenstrennung

Befund: 72 % der Hausärzte und 78 % der Orthopäden berichten, mindestens einmal einen Regress erlebt zu haben. 47 % (HA) / 55 % (Ortho) geben an, die Regressgefahr beschäftige den Praxisalltag „stark oder sehr stark“. 51 % der Hausärzte überweisen „zumindest gelegentlich trotz Indikation“ an Spezialisten. 85 % haben mindestens einmal aus Regressangst eine Verordnung unterlassen.

Evidenzbasis: Ribbat L, Linde K, Schneider A, Riedl B (2023): Gesundheitswesen 85(2): 111–118. DOI: 10.1055/a-1594-2527. Bundesweite Zufallsstichprobe, je 1.000 Hausärzte und 1.000 Orthopäden, Rücklauf 41 % / 39 % (n=770). Lehrstuhl für Allgemeinmedizin TU München.

Einschränkung: Die Studie misst **V1+V2 zusammen, ohne Verfahrenstrennung**. Sie misst subjektive Wahrnehmung und selbstberichtetes Verhalten, keine objektiven Versorgungsergebnisse. Eine unabhängige Replikation steht aus. Der kausale Schluss „Prüfdruck → Unterversorgung“ ist nicht empirisch geschlossen (Einwand 1 der Studie). Die Studie ist der beste verfügbare Datenpunkt, nicht der abschließende Beweis.

Rechnerische Plausibilisierung: Ein Poisson-Modell mit drei Ankern ($\lambda = 0,30$ aus der BMG-Bundesrechnung, $\lambda = 0,85$ aus der KV-Nordrhein-Zahlungsquote, $\lambda = 1,48$ aus der KV-Nordrhein-Antragsquote) ergibt eine Bandbreite: Eine deutliche Mehrheit der Ärzte (60–99 % über drei Jahre, je nach gezähltem Ereignistyp — abgeschlossenes Verfahren, Zahlung oder

Antrag) ist betroffen. Die 72 % Ribbat-Erfahrungsrate ist damit rechnerisch plausibel, unabhängig von der "unter 1 %"-Durchsetzungsquote (vgl. ST-001 Abschn. 3.4, Summierungsrechnung).

2.8 Spieltheoretisches Nash-Gleichgewicht

Befund: Bei einem wahrgenommenen Regressrisiko von ca. 15 % ($P_{\text{perceived}}$) wird „nicht verordnen“ zur dominanten Strategie des Arztes. Das Ergebnis ist ein Pareto-suboptimales Nash-Gleichgewicht: Arzt verliert (ethischer Stress, Mehrarbeit), Patient verliert (Unterversorgung), Kasse gewinnt nichts (zahlt später die Hospitalisierung), System verliert die Folgekosten. Niemand will dieses Gleichgewicht — alle spielen es individuell rational.

Zusätzlich identifiziert die Studie ein Solidaritäts-Gefangenendilemma innerhalb der Ärzteschaft: Wer öffentlich kämpft, wird zur Zielscheibe. Wer schweigt, profitiert vom Erfolg anderer.

Evidenzbasis: Verhaltensökonomische Modellierung auf Basis der Ribbat-Daten, Kahneman/Tversky-Verlustaversion ($\lambda \approx 2,25$), KBV-Berufsmonitoring.

Einschränkung: Die Schwellenwerte sind Modellannahmen. Die formale Durchmodellierung mit Auszahlungsmatrizen und Sensitivitätsanalysen ist als Folgeanalyse vorgesehen, liegt aber noch nicht vor.

2.9 Folgekostenrechnung (0,9–1,7 Mrd. EUR, Szenario-Annahme)

Befund: Die Studie schätzt die Folgekosten regressangst-induzierter Fehlversorgung im Dreistufenmodell:

Stufe	WertQuelle
Systemrahmen (ACSC + Non-Adhärenz, vor Attribution)	7–17 Mrd. EUR/Jahr WldO, Zi, DIMDI HTA 65
× Attributionsrate (konservativ)	5 % Szenario-Annahme
= Regress-Folgekosten (Gesamtbandbreite)	0,9–1,7 Mrd. EUR/Jahr Eigene Hochrechnung
davon mittleres Szenario	1,1 Mrd. EUR/Jahr Sensitivitätstabelle ST-001 Abschn. 4.3

Dem stehen durchgesetzte Regresse von geschätzt 5–50 Mio. EUR/Jahr gegenüber. **Szenario-Verhältnis Schaden zu Einnahme: ca. 100:1 bis 1.000:1.**

Im mittleren Szenario wären ca. 6.230 vermeidbare Hospitalisierungen und ca. 125 Todesfälle pro Jahr anteilig mit regressangst-induzierter Unterversorgung assoziierbar.

Evidenzbasis: WldO Krankenhaus-Report, Zi 2021, DIMDI HTA 65, OECD Health at a Glance 2025, Ribbat 2023, eigene Hochrechnung mit Sensitivitätstabelle.

Einschränkung: Diese Zahlen sind ein illustratives Gedankenexperiment auf Basis von Szenario-Annahmen, kein kausalanalytisch abgesicherter Befund. Insbesondere die Attributionsrate (5 %) und die Frequenz unterlassener Verordnungen sind Modellannahmen. Keine der verfügbaren Studien misst diese Größen direkt. Der unvollständige Nenner: Die Abschre-

ckungswirkung des Systems (verhinderte Mehrausgaben) ist real, aber nicht quantifiziert. Die 100:1-Zahl bildet den worst case für das System ab, nicht den Erwartungswert.

2.10 Normativer Schadensbegriff und V2b-Unheilbarkeit

Befund: Der normative Schadensbegriff des BSG (B 6 KA 5/09 R, 2010) definiert: Der Schaden der Kasse gilt als ab Bezahlung der formal fehlerhaften Verordnung eingetreten — unabhängig davon, ob das Medikament medizinisch indiziert war. Nach Verfahrenseinleitung ist der Formfehler nicht mehr heilbar. Das BSG hat dies 2025 (B 6 KA 9/24 R) bei 491.000 EUR Stempel-Regress bestätigt: Das Argument der medizinischen Indikation wurde als irrelevant erklärt.

2024 schloss das BSG die Differenzkostenregelung für „unzulässige“ Verordnungen (= Formfehler) ausdrücklich aus (B 6 KA 5/23 R; B 6 KA 10/23 R).

Evidenzbasis: BSG-Rechtsprechung (direkt verifiziert).

Einschränkung: In seltenen Fällen haben Gerichte trotz Formfehler zugunsten des Arztes entschieden (SG Mainz 2022: 260.000 EUR als rechtsmissbräuchlich zurückgewiesen; LSG BaWü 2025: Doppelprüfungsverbot). Diese Ausnahmen belegen durch ihre Seltenheit, wie wenig Schutz der Rechtsweg typischerweise bietet.

2.11 Fehlversorgung bidirektional (Unter- UND Überversorgung) — SVR-Trias

Befund: Die deutsche Regressangst erzeugt — anders als das US-amerikanische Tort Law — eine Fehlversorgung in zwei Richtungen zugleich (Begrifflichkeit: SVR 2000/2001, § 135a SGB V):

- **Unterversorgung bei Verordnungen** (§ 70 SGB V): Ärzte verschreiben weniger, vermeiden teure Medikamente, verzichten auf Off-Label-Therapien.
- **Überversorgung bei Diagnostik und Überweisungen** (§ 12 SGB V): Ärzte veranlassen zusätzliche Bluttests, überweisen an Fachärzte, fordern Bildgebung an — nicht weil der Patient es braucht, sondern zur eigenen Absicherung. (Goetz 2024: 54 % wöchentlich unnötige Labortests; Ribbat 2023: 51 % überweisen trotz eigener Kompetenz.)

Der präzisere Begriff ist **Fehlversorgung** als Querkategorie: Das System lenkt ärztliche Ressourcen von der Therapie in die Absicherung. **Schadens-Verschiebung zum Patienten** — in beide Richtungen: (a) *medizinisch* iatrogene Risiken und Overdiagnosis-Belastung; (b) *finanziell und zeitlich* zusätzliche Arzttermine, Zuzahlungen, Wartezeiten, Urlaubstage, Anfahrtswege, Begleitpersonen. Was das Prüfsystem als „Wirtschaftlichkeit“ einspart, zahlt der Patient doppelt — als verzögerte Therapie *und* als Zeit-/Wegelast unnötiger Zusatzleistungen.

Evidenzbasis: Ribbat 2023, Goetz 2024, internationaler Vergleich (Kessler & McClellan 1996, Currie & MacLeod 2008, Mello et al. 2010).

Einschränkung: Unterversorgung ist methodisch viel schwerer zu messen als Überversorgung. Wenn ein Arzt eine notwendige Verordnung unterlässt, taucht es nirgends auf — außer später in der Hospitalisierungsstatistik, ohne Ursachenzuschreibung.

2.12 Asymmetrische Sanktionsstruktur ohne Gegengratifikation

Befund: Der niedergelassene Arzt steht unter einem **bidirektionalen Sanktionsdruck** ohne institutionelle Gegengratifikation. (a) Bei *Überversorgung* drohen Regress (§§ 106, 106b SGB V),

Einzelfallregress (§ 48 BMV-Ä), Disziplinarverfahren (§ 81 Abs. 5 SGB V) und im Wiederholungsfall Zulassungsentzug (§ 95 Abs. 6 SGB V). (b) Bei *Unterversorgung* greifen zivilrechtliche Haftung (§§ 630a ff., 280, 823 BGB), ggf. Strafrecht (§§ 223, 229 StGB), Verfahren der Schlichtungsstellen/Gutachterkommissionen (bundesweit rund 12.000/Jahr, Bestätigungsquote ca. 24–25 %) sowie berufsrechtliche Maßnahmen bis zum Approbationsentzug (§ 5 BÄO). Beiden Fehlerkonten steht **kein** positives Rückkopplungssignal gegenüber: Leitliniengerechtes, maßvolles Verordnen wird im deutschen Vertragsarztsystem weder formal honoriert noch öffentlich anerkannt. Internationale Pendants wie der britische *Quality and Outcomes Framework* (QOF) oder die *Choosing-Wisely*-Initiative zeigen, dass solche Mechanismen möglich sind — und dass Dissemination ohne strukturelle Verankerung wirkungslos bleibt.

Konsequenz: Der rationale Arzt minimiert *Exposition* (in beide Richtungen), er maximiert nicht Qualität — Exzellenz bleibt ökonomisch unbelohnt. Das ist nicht Ausdruck mangelnder Professionalität, sondern die erwartbare Antwort auf ein Anreizfeld, in dem Fehler teuer und Exzellenz unbelohnt sind. Lösungsraum Rang 4 (positive Rückkopplung / Unauffälligkeitszertifikat / Qualitätsbonus) adressiert diesen Befund.

Evidenzbasis: Schlichtungsstellen-Statistik 2023, MD-Bund 2023; NHS QOF (Doran 2006; Forbes 2017); P4P-Kritik (Roland/Campbell 2009; Van Herck 2010); McGuire/Pauly 1991; Reviews zu Low-Value-Care-Interventionen (Cliff 2021 zu Choosing Wisely; Colla 2017 als Systematic Review); DGIM “Klug entscheiden”; DEGAM-S2e Überversorgung.

Einschränkung: Der QOF-Vergleich ist strukturell, nicht normativ: P4P-Systeme haben dokumentierte *unintended consequences* (Gaming, Exklusionen). Der Befund ist, dass *irgendein* positives Rückkopplungssignal existieren sollte — nicht, dass QOF eins zu eins importiert werden muss.

2.13 V2-Durchsetzung im Vergleich versteckt (70–80 %)

Befund: Geschätzt 70–80 % der von V2 betroffenen Ärzte schließen Vergleiche (typisch 30–50 % des Regressbetrags). Der Vergleich ist die Durchsetzung — nur außerhalb des Gerichts. Er erscheint in der Statistik als „kein Regress“, obwohl der Arzt gezahlt hat. Die Verwerfungsquote misst damit nicht die Qualität der Anträge, sondern die Gegenwehrstärke der Betroffenen.

Nur zwei von fünf Beendigungswegen produzieren eine inhaltliche Feststellung (Ablehnungsbescheid oder Gerichtsurteil). Da fast alle Verfahren vor Gericht enden, bleibt die Systemqualität dauerhaft ungemessen.

Evidenzbasis: Praxisberichte von Regressberatern und ärztlichen Fachverbänden, Verfahrenstrukturanalyse. *Belastbarer Annäherungswert (Update v1.3)*: KV Nordrhein gibt gegenüber dem *Deutschen Ärzteblatt* an, dass ca. 95 % der Einzelfallprüfungen zu einem Regress führen (Vergleich zählt rechentechnisch als Regress) — die ST-001-Schätzung 70–80 % Vergleich passt damit konsistent in den 95 %-Korridor.

Einschränkung: Es existiert **keine publizierte Studie** zur exakten Vergleichsquote bei V2 (Anteil der Regress-Beendigung durch Vergleich vs. rechtskräftige Festsetzung). Die 70–80 %-Schätzung beruht auf Praxisberichten, nicht auf systematischen Erhebungen.

2.14 Container-Genealogie (9 Normcontainer)

Befund: 1989 reichte ein einziger Paragraph (§ 106 SGB V) für die gesamte Wirtschaftlichkeitsprüfung. 2026 sind daraus fünf ambulante (§§ 106, 106a, 106b, 106c, 106d), zwei stationäre

(§§ 275, 275c), § 48 BMV-Ä plus Rahmenvorgaben und bis zu 17 regionale Prüfvereinbarungen geworden. Die geschriebene Regelfläche hat sich in 35 Jahren etwa verachtfacht. Der Regelungsgehalt ist im Kern derselbe geblieben.

Drei methodisch besonders aufschlussreiche Wanderungen: (1) Die § 106a-Umbenennungsfälle (2017), (2) die Auslagerungskaskade der Einzelfallprüfung auf drei Ebenen, (3) die parallel-gegenläufige Operation ambulant/stationär. Sieben von zehn identifizierten strukturellen Inkonsistenzen im Normgefüge wären mit minimalem gesetzgeberischem Aufwand fixbar. Sie werden seit Jahren nicht behoben.

Evidenzbasis: Gesetzestexte (GRG 1989, GSG 1992, GKV-VSG 2015, TSVG 2019), BT-Drucksachen, historische Fassungen via BGBl.

Einschränkung: Die Containeranalyse zeigt Komplexitätszunahme, nicht kausal Dysfunktion. Die praktischen Folgen lassen sich nur über die Befunde aus Teil III (Verhaltensökonomie) und Teil V (institutionelles Schweigen) der Studie ableiten.

2.15 Internationaler Vergleich

Befund: Deutschland und die Schweiz sind in Westeuropa praktisch die einzigen Länder mit flächendeckender individueller Regress-Prüfung gegen einzelne Ärzte. Frankreich entwickelt seit 2023 eine strukturell parallele Debatte unter dem Begriff „délit statistique“ (MSO/MSAP-Verfahren der CNAM). Andere Länder (UK, NL, Skandinavien) steuern ärztliches Ordnungsverhalten über positive Anreize (QOF), Capitation, zentrale Preisbildung oder professionelle Selbstregulation — ohne Individual-Sanktionen.

Evidenzbasis: OECD Health at a Glance, NHS-QOF-Dokumentation, französische Primärquellen (MG France, FMF, Le Quotidien du Médecin, CNAM-Kontrollzahlen 2024).

Einschränkung: Die Vergleichbarkeit ist durch unterschiedliche Systemarchitekturen begrenzt. Der französische Fall betrifft primär Krankschreibungen, nicht Arzneimittel.

2.16 Goodhart's Law / Campbell's Law

Befund: Das Proxy-Versagen des Prüfsystems — Formkonformität wird gemessen statt medizinischer Qualität — ist kein Einzelfall, sondern eine bekannte systemische Pathologie. Goodhart's Law („When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure“) und Campbell's Law beschreiben exakt diesen Mechanismus. Die Prüfquote wird zum Ziel, die Formkonformität zum Messobjekt — und beide verlieren dadurch ihre diagnostische Aussagekraft.

Evidenzbasis: Theoriegestützte Analyse, angewandt auf die empirischen Befunde aus Teilen I–III der Studie.

Einschränkung: Die Anwendung ist analytisch, nicht empirisch getestet.

2.17 Doppelfunktion: Evidenz in formaler Verkleidung (CORE4)

Befund: Die bisherige Analyse behandelte „Formalität“ als einheitlich medizinisch irrelevant. Das war zu pauschal. Die V2-Prüfanlässe zerfallen in drei Kategorien:

Kat.	Anteil	Charakter
A	~35 %	Rationale Evidenzsteuerung (Biosimilar-Pflicht, Off-Label, AM-RL)
B	~40 %	Reine Formalkontrolle (Stempel, ICD-Kodierung)
C	~25 %	Bürokratie-Overhead (Bagatelle <300 EUR)

Das System hat zwei parallele Evidenzkanäle: Fortbildungspflicht (CME, § 95d SGB V, *präventiv*) und Einzelfallprüfung (V2, *punitiv*). Der Arzt erhält kein Lernsignal vor dem Regress. Die Forderung verschiebt sich: Nicht Abschaffung der Evidenzsteuerung (Kat. A), sondern Ergänzung des punitiven Kanals um einen edukativen.

Evidenzbasis: AOK BaWü Prüfungsthemenliste 2025; SpiFa Bayern; AM-RL-Struktur; § 95d SGB V.

Einschränkung: Die Prozentanteile (35/40/25) sind Schätzungen auf Basis der Prüfungsthemenlisten, nicht empirisch gemessen. Eine verfahrensgetrennte Aufschlüsselung nach V2a/V2b existiert nicht.

Originalität: Prior-Art-Check (Opus-Agent, 20+ Suchanfragen): Die Synthese — Regress + CME als zwei parallele Evidenzkanäle (punitiv vs. edukativ) — ist nirgends publiziert. Stallberg, IQWiG, Zeschick und Gandjour thematisieren Einzelaspekte; die Verbindung ist originär.

2.18 Foucault-Panoptikum

Befund: Das Wirtschaftlichkeitsprüfsystem erfüllt die drei Kernmerkmale des Foucaultschen Panoptikums: (1) Asymmetrische Sichtbarkeit — der Arzt weiß nicht, ob und wann seine Verordnungen geprüft werden, die Kasse sieht seine Daten in Echtzeit. (2) Internalisierung der Kontrolle — 72 % der Hausärzte ändern ihr Verordnungsverhalten präventiv, nicht weil sie geprüft werden, sondern weil sie geprüft werden *könnten*. (3) Ökonomie der Macht — die niedrige V1-Regressquote ist maximale Effizienz: Das Screening allein erzeugt flächendeckende Verhaltensänderung, ohne viele Regresse durchsetzen zu müssen.

Das Prüfsystem ist nicht nur ein schlechtes Messinstrument — es ist ein hochwirksames Disziplinierungsinstrument, das gerade *weil* es nicht präzise misst, seine größte Wirkung entfaltet.

Evidenzbasis: Theoriegestützte Analyse (Foucault, *Surveiller et punir*, 1975), angewandt auf die Ribbat-Befunde und die Verfahrensstrukturanalyse.

Einschränkung: Theoretische Einordnung, nicht empirischer Nachweis der Intentionalität.

3 Vorgeschlagene Maßnahmen (KNV-Tabelle)

Die Studie bewertet 14 Maßnahmen nach Aufwand, politischer Realisierbarkeit, erwartetem Nutzen und Kosten-Nutzen-Verhältnis (KNV). Die Rangfolge:

Rg	#	Maßnahme	Aufw.	Real.	Nutz.	KNV	Zeit
1	1	Halbsatz-Streich § 106b Abs. 2 S. 4 (Beratungsschutz für V2)	ger.	hoch	hoch	A+	kurz
2	2	Sichtbarmachung § 48 BMV-Ä im SGB V	ger.	hoch	mittel	A	kurz
3	3	Bundeseinheitliche Bagatellgrenze	ger.	hoch	mittel	A	kurz
4	4	Positive Rückkopplung (Unauff.-Zertifikat)	ger.	hoch	mittel	A	kurz
5	5	Unabh. Effizienzprüfung des Prüfsystems	ger.	hoch	hoch	A	mittel
6	6	Publikationspflicht der Prüfungsstellen	ger.	mittel	transf.	A–	kurz
7	7	PP-003: Regress-Transparenzportal	mittel	mittel	hoch	B+	mittel
8	8	Öffnung der operativen Prüfkataloge	mittel	mittel	hoch	B+	mittel
9	9	Kostenfolgen-Pflichtabschätzung bei Anträgen	mittel	mittel	mittel	B	mittel
10	10	Maximale Gesamtverfahrensdauer	mittel	mittel	mittel	B	mittel
11	11	Open-Source-Verordnungstool	mittel	mittel	mittel	B	mittel
12	12	Sanktionsfolge für unbegründete Kassenanträge	mittel	niedr.	hoch	B	lang
13	13	IFG-Anfragen an Prüfungsstellen	ger.	niedr.	ger.–m.	C	kurz
14	14	Governance-Pharmakovigilanz	hoch	niedr.	transf.	B–	lang
15	15	Versorgungsprüfung (§§ 70, 135a SGB V) — Messinstrument für Unter-/Fehlversorgung (symmetrische Gegenprüfung zur WiP)	hoch	mittel	transf.	B	lang

Erläuterung der wichtigsten Maßnahmen:

- **Rang 1 (Halbsatz-Streich):** Eine Zeile Gesetzestext würde die strukturelle Asymmetrie zwischen V1 und V2 beseitigen. Damit gälte auch für Einzelfallprüfungen, dass beim erstmaligen Anlass eine Beratung statt eines Regresses erfolgt. **Dogmatisch wichtig:** Die Beratung nach § 106b Abs. 2 S. 2 SGB V ist eine *Regelungsentscheidung mit Verwaltungsaktqualität* (nicht nur ein informeller Hinweis; BSG B 6 KA 21/15 R, B 6 KA 1/17 R). Sie begründet einen Vertrauenstatbestand und schließt spätere Regresse für denselben Sachverhalt aus. Bereits 2015 in der KBV-Kritik vorgeschlagen.
- **Rang 2 (§ 48 BMV-Ä):** Der wichtigste existenzvernichtende Regressgrund (rund 490.000 EUR Stempelregress, BSG B 6 KA 9/24 R vom 27.08.2025) lebt außerhalb des SGB V in einem Kollektivvertrag. Wer „nur“ das Gesetz liest, übersieht ihn. Rein redaktionelle Änderung, kein Akteur verliert.
- **Rang 5 (Effizienzprüfung):** Kein Akteur (BRH, BAS, SVR, Bundestag) prüft die Wirtschaftlichkeit der Wirtschaftlichkeitsprüfung. Ein gesetzlicher Evaluationsauftrag alle 5 Jahre würde die institutionelle Selbsterhaltungsdynamik durchbrechen.
- **Rang 6 (Publikationspflicht):** Ohne veröffentlichte Vollzugsstatistiken ist jede Effizienzdiskussion unmöglich. Die spieltheoretische Analyse identifiziert den Abbau asymmetrischer Information als wirkungsmächtigste Einzelintervention.

4 Bedeutung für das Regress-Transparenzportal (PP-003)

PP-003 positioniert sich im oberen Mittelfeld der Maßnahmenrangliste (**Rang 7 von 14**, KNV: B+).

Strategische Funktion: PP-003 ist der „Plan B, der Plan A erzwingen soll.“ Wird die Publikationspflicht der Prüfungsstellen (Rang 6) politisch realisiert, wird das Portal teilweise überflüssig —

und genau das wäre das gewünschte Ergebnis. Das Portal erzeugt den informationellen Druck, die Reformhebel den institutionellen. Eines ohne das andere verpufft.

Was PP-003 leisten kann:

- Erstmals verfahrensgetrennte (V1 vs. V2) Daten aus ärztlicher Perspektive erheben
- Die Risikokalibrierung der Ärzte korrigieren (Aggregat-Zahlen statt Anekdoten)
- Politischen Reformdruck aufbauen durch Sichtbarmachung der Datenlücke
- Zivilgesellschaftlichen Druckaufbau für die Maßnahmen der Ränge 1–6 leisten

Was PP-003 nicht leisten kann:

- Die strukturelle Asymmetrie zwischen V1 und V2 beseitigen (dafür braucht es Rang 1)
- Die fehlende Effizienzaufsicht ersetzen (dafür braucht es Rang 5)
- Das Compliance-Theater auf Kassenseite verhindern (Transparency Paradox nach Bernstein 2012)
- Den kausalen Schluss Prüfdruck → Unterversorgung empirisch schließen

Robustheit gegenüber Kritik: PP-003 berücksichtigt das Transparency Paradox (Bernstein 2012) durch drei Gestaltungsentscheidungen: (1) Wahlkabinen-Prinzip (kryptografische Trennung), (2) k -Anonymität ($k \geq 5$), (3) Fokus auf Aggregate statt Einzelfälle. Dennoch ist das Portal ein notwendiger, aber nicht hinreichender Schritt.

5 Was am ehesten umgesetzt werden sollte

Höchste Priorität (Ränge 1–6): Geringe Aufwände, hohe Realisierbarkeit, kurzfristig umsetzbar

Die Ränge 1–6 teilen drei Eigenschaften: Sie kosten wenig, sind politisch anschlussfähig und können innerhalb eines Jahres wirksam werden.

Der effizienteste Einzelhebel ist der Halbsatz-Streich (Rang 1): Eine Zeile Gesetzestext würde den wichtigsten einzelnen Treiber der Regressangst eliminieren — die Tatsache, dass bei der Einzelfallprüfung im Gegensatz zur Auffälligkeitsprüfung kein „Beratung vor Regress“ vorgesehen ist.

Der transformativste Hebel ist die Publikationspflicht der Prüfungsstellen (Rang 6): Solange keine Vollzugsstatistiken existieren, ist jede Reformdebatte eine Debatte ohne Datenbasis.

Die politisch einfachsten Hebel sind die Ränge 2–4: rein redaktionelle Änderungen (Sichtbarmachung § 48 BMV-Ä), bereits in KBV-Forderungslisten enthaltene Maßnahmen (Bagatellgrenze) oder KV-interne Maßnahmen ohne Gesetzesänderung (Unauffälligkeits-Zertifikat).

Mittlere Priorität (Ränge 7–11): Ergänzende Maßnahmen mit mittlerem Aufwand

PP-003 (Rang 7) entfaltet seine volle Wirkung erst im Verbund mit den Rängen 1–6. Als zivilgesellschaftlicher Druckaufbau ist es besonders dann wertvoll, wenn die politischen Hebel nicht zeitnah gezogen werden.

Langfristige Vision (Ränge 12–14): Strukturelle Reformen

Die Governance-Pharmakovigilanz (Rang 14) — eine regelmäßige, unabhängige Bewertung der Versorgungs-Nebenwirkungen regulatorischer Maßnahmen — wäre die umfassendste Systemänderung. Sie hat den höchsten transformativen Nutzen, aber die niedrigste politische Realisierbarkeit.

6 Offengebliebene Fragestellungen

6.1 Fehlende V2-Pipeline-Daten

Für die Einzelfallprüfung (V2) existiert keine publizierte Pipeline-Statistik. Weder die Gesamtzahl der Anträge, noch die Verwerfungsquote, noch die Vergleichsquote, noch die Verfahrensdauer wird öffentlich publiziert. Die gesamte Spalte „k. D.“ (keine Daten) in den Pipeline-Tabellen der Studie wartet auf Füllung.

6.2 IFG-Anfragen (Frist ca. 10.05.2026)

Neun IFG-Anfragen an BMG, BAS, KBV, GPE und weitere Stellen wurden am 10.04.2026 eingereicht. Die Antwortfrist beträgt 30 Tage (§ 7 Abs. 5 IFG). Erste Empfangsbestätigungen liegen vor. Die wichtigsten erwarteten Erkenntnisse:

- **A1 + A2 (BMG, GPE RLP):** Würden erstmals die V2-Pipeline mit realen Zahlen füllen — der „größte einzelne Qualitätssprung“ für die Studie.
- **A3 (BAS):** Würden den Niskanen-Befund (GPE-Selbsterhaltung) empirisch untermauern oder widerlegen.
- **A6 (BRH):** Die Antwort „keine Sonderprüfung seit 2005“ wäre selbst ein Befund.
- **A9 (BMG):** Würde erzwingen, dass das BMG schriftlich zu konkreten Schwachstellen im Normgefüge Stellung nimmt.

Auch Verweigerungen sind publizistisch verwertbar: „Diese Daten liegen uns nicht vor“ bestätigt die diagnostizierte Transparenzlücke.

6.3 Kausalitätslücke (Prüfdruck → Unterversorgung)

Der kausale Schluss „Prüfdruck → verändertes Ordnungsverhalten → Unterversorgung → Patientenschäden“ ist nicht empirisch geschlossen. Die Studie verfügt nicht über eine kausalanalytische Studie, die Versorgungsergebnisse direkt mit Prüfintensität korreliert — etwa einen Vergleich von KV-Regionen mit unterschiedlicher Einzelfallprüfungsfrequenz. Ein solches natürliches Experiment wäre der stärkste Beleg, existiert aber nicht.

6.4 Ribbat-Replikation ausstehend

Ribbat et al. (2023) ist die einzige große deutsche Befragungsstudie, die spezifisch die Auswirkungen der Regressangst auf das Ordnungsverhalten misst. Eine unabhängige Replikation — idealerweise mit verfahrensgetreuer Erhebung (V1 vs. V2) — steht aus. Zwei empirische Befunde würden die Kausalkette erheblich schwächen:

1. Eine Replikation mit weniger als 20 % berichtetem Verhaltenseffekt

2. Eine Korrelationsanalyse zwischen Prüfintensität und Verordnungsvolumen, die keinen Zusammenhang zeigt

6.5 Folgekostenrechnung empirisch nicht fundiert

Die Hochrechnung (0,9–1,7 Mrd. EUR/Jahr) beruht auf Szenario-Annahmen. Insbesondere die Attributionsrate (5 %) und die Frequenz unterlassener Verordnungen sind Modellannahmen. Die Modellrechnung ersetzt keine kausalanalytische Studie. Eine systematische Prüfung durch eine zuständige Stelle (BRH, SVR, IGES) hat bisher nicht stattgefunden.

6.6 Abschreckungswirkung nicht quantifiziert

Die Studie rechnet nur Kosten (Unterversorgung, Defensivmedizin, Folgeschäden), nicht den Nutzen des Prüfsystems (verhinderte Mehrausgaben durch Abschreckung). Diese Abschreckungswirkung ist real und schwer messbar. Eine vollständige Kosten-Nutzen-Analyse müsste sie im Nenner berücksichtigen.

6.7 V2a/V2b-Verteilung unbekannt

Welcher Anteil der Einzelfallprüfungen V2a (unwirtschaftlich) und welcher V2b (unzulässig/Formfehler) betrifft, ist nicht öffentlich bekannt. Ohne diese Differenzierung kann die Schärfe des Befunds nicht kalibriert werden.

6.8 Automatisiertes Screening durch Kassen — offene Rechtsfrage

Ob Krankenkassen tatsächlich systematisch alle Verordnungsdaten mit Prüfsoftware scannen, um daraus Einzelfallprüfungsanträge zu generieren, ist empirisch nicht belegt. Belegt ist, dass die technischen Mittel existieren und dass das Volumen (KV Nordrhein: ca. 20.000 Anträge/Jahr) schwer allein mit zufälligen Verdachtsmomenten erklärbar ist. Die verfassungsrechtliche Einordnung (BVerfG Hessendata 2023, 1 BvR 1547/19) ist argumentativ vertretbar, aber gerichtlich nicht geklärt.

6.9 GPE-Kosten extern nicht verifizierbar

Die Kosten der bundesweiten Prüfinfrastruktur (ca. 600–900 Stellen) sind aus offenen Quellen nicht verifizierbar. Die GPE sind keine staatlichen Behörden, tauchen in keinem Haushalt auf, und der Bundesrechnungshof prüft sie nicht. Diese strukturelle Nicht-Verifizierbarkeit ist selbst ein Befund.

7 Methodische Transparenz

Die Studie entstand in einem mehrstufigen, KI-gestützten Analyseprozess im April 2026 (geschätzte Gesamtarbeitszeit ca. 60–80 Stunden, Mensch + KI kombiniert). 31 eigenständige Recherchestränge wurden durchgeführt und in eine integrierte Argumentation überführt.

Multi-Modell-Architektur: Vier Instanzen arbeitsteilig — Claude (Opus 4.6, Primäranalyse und Synthese), Copilot (GPT-4o, Konzeptschärfung und Fehlkonzept-Erkennung), Gemini (Deep Research, Theorierahmen und Quellenergänzung), LG/Mensch (Fragestellungen, Richtungsentscheidungen, finale Freigabe).

Bias-Management: Cross-Model-Divergenzen wurden systematisch als Signal genutzt. Fünf dokumentierte Hypothesenrevisionen (u. a. Datierung der Einzelfallprüfung: GSG 1992 → GRG 1988; Moosazadeh-Fehlzuordnung → Zheng 2023; Kostenmodell: Systemrahmen → Dreistufenmodell nach Copilot-Review). Ein eigener Devil's-Advocate-Agent versuchte systematisch, die zentrale These zu widerlegen.

Cross-Source-Divergenz (Phase XIV): 15 spezialisierte Agenten (6 Opus, 9 Sonnet) recherchierten parallel mit 25 Datenpunkten aus 14 unabhängigen Domains. Zentrale Lektion: Cross-Model-Divergenz kontrolliert Modell-Bias, aber nicht Quellen-Bias. Erst Multi-Quellen-Recherche brachte die SpiFa-Bayern- und BMG-Daten ans Licht. Zwei Prior-Art-Checks bestätigten: Beide zentralen Synthesen (Definitionsdivergenz; Evidenz in formaler Verkleidung) sind originär.

Halluzinationskontrollen: Gemini-Outputs erforderten systematischen Double-Check bei aktuellen politischen Ereignissen (dokumentierte Fälle: Moosazadeh-Fehlzuordnung, französische Protestzahlen). Jede Quelle wurde gegen die Originalpublikation geprüft.

Grenzen der Evidenz: Die Studie behauptet **nicht**, dass das Wirtschaftlichkeitsprüfsystem abgeschafft werden sollte, dass alle Regresse ungerechtfertigt sind, oder dass Ärzte keiner Kontrolle bedürfen. Sie behauptet:

1. Das System misst überwiegend nicht, was es zu messen vorgibt (Zertifikatsfehler) — wobei ~35 % der V2-Prüfungen durchaus evidenzbasierte Steuerung leisten. Das Problem ist nicht die Evidenz, sondern der Kommunikationskanal: punitiv statt edukativ.
2. Die Einzelfallprüfung ist strukturell asymmetrisch ausgestaltet (kein Beratungsschutz, normativer Schadensbegriff bei V2b).
3. Die "unter 1 %" -Zahl und die 72 %-Erfahrungsraten messen verschiedene Dinge (Definitionsdivergenz, Faktor ~500×). Die Diskrepanz ist ein Messproblem, kein Wahrnehmungsfehler.
4. Die Datenlage ist so dünn, dass weder Befürworter noch Kritiker ihre Position empirisch vollständig belegen können.
5. Die Transparenzlücke ist nicht zufällig, sondern strukturell — und sie zu schließen wäre der wirksamste einzelne Schritt zur Versachlichung der Debatte.

Wo die Studie Szenario-Annahmen macht, sind diese als solche gekennzeichnet. Wo Wertungen vorgenommen werden, sind sie als Wertungen kenntlich. Wo Befunde mehrere Lesarten zulassen, werden alle Lesarten dargestellt.

Vollständige Studie: ST-001 Systemtheoretische Aufarbeitung der Regressangst (Arbeitsversion v0.22, April 2026)

Begleitstudie zu: PP-003 Regress-Transparenzportal (v3.1)

Lizenz: CC BY 4.0

Kontakt: hallo@um-bruch.org | um-bruch.org

Repository (Quellen, Recherche, Versionen): github.com/um-bruch/regressangst

Companion-Software (Open Source): github.com/um-bruch/verordnungsampel – *Verordnungs-Ampel, Werkzeug zur Regress-Risikoindikatoren-Anzeige ohne Gewähr.*

Änderungshistorie:

v1.0 (April 2026) — Erstversion, basierend auf ST-001 v0.11. 15 Befunde, KNV-Tabelle (14 Maßnahmen), PP-003-Einordnung, 9 offene Forschungsfragen.

v1.0+CORE4 (April 2026) — CORE4-Integration: 2 neue Befunde (Definitionsdivergenz mit Drei-Schichten-Tabelle; Doppelfunktion mit A/B/C-Kategorien). V2-Datenabschnitt korrigiert (BMG 47.000, SpiFa Bayern 13.332). “Grenzen der Evidenz” auf 5 Punkte erweitert. Multi-Agenten-Experiment + Prior-Art-Checks in Methodische Transparenz. ST-001-Referenz auf v0.12 (87 Seiten). 13 Seiten.

v1.1+CORE4 (April 2026) — Synchronisation mit ST-001 v0.14 (95 Seiten) nach 18-facher Review-Chain: Poisson-Bandbreite $\lambda = 0,30\text{--}1,48$ mit 60–99 %-Gesamtbandbreite ergänzt; Beratung als Regelungsentscheidung (§ 106b Abs. 2 S. 2 SGB V; BSG B 6 KA 21/15 R, B 6 KA 1/17 R) präzisiert; übergeordneter Zertifikatsfehler und SVR-Trias (§§ 70, 135a SGB V) verankert; Versorgungsprüfung als neue KNV-Zeile 15; Folgekosten-Detaillierung auf mittleres Szenario $\approx 1,1$ Mrd. EUR; BSG B 6 KA 9/24 R Datum (27.08.2025) und Summe (rund 490.000 EUR) vereinheitlicht.

v1.2 (April 2026, 2026-04-14) — Synchronisation mit ST-001 v0.15 (P1-Block): **Genre-Klärung** in der Zusammenfassung — “multiperspektivische Bestandsaufnahme mit Pilot-Charakter” statt Original-Studie; **quantitative Einschätzung** in Abschnitt V2a/V2b: 60–65 % der V2-Verfahren (Kategorie B + verfahrensfremd) unter zweitem Zertifikatsfehler, 35–40 % (Kategorie A) codieren G-BA-Evidenz punitiv statt edukativ (Devil’s-Advocate-Befund aus Einwand 5 in Hauptthese). Untertitel und ST-001-Referenz auf v0.15 angehoben.

KI-Transparenzhinweis: Dieses Dokument wurde unter extensivem Einsatz von KI-Sprachmodellen (u. a. Anthropic Claude, Microsoft Copilot, Google Gemini) erarbeitet. Es wurden mehrere Kontroll- und Reviewzyklen durchgeführt — KI-gestützt und menschlich. KI-Modelle neigen zu Halluzinationen; Fehler sind trotz sorgfältiger Prüfung nicht ausgeschlossen. Wir korrigieren dokumentierte Fehler und veröffentlichen verbesserte Versionen. Dieses Dokument stellt keine Rechtsberatung dar. Hinweise: hallo@um-bruch.org